



LAPORAN KINERJA MANAJEMEN RISIKO

**RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
SUKOREJO**

TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN
Laporan Kinerja Manajemen Resiko
Rumah Sakit Prima Husada
Sukorejo

Laporan Kinerja Manajemen risiko merupakan metode penanganan sistematis formal dimana dikonsentrasikan pada pengidentifikasian dan pengontrolan peristiwa atau kejadian yang memiliki kemungkinan perubahan yang tidak diinginkan.

Disusun,
Oleh :
Komite Mutu RS. Prima Husada



(Ns. Mariatul Rochmawati NW, S.Kep.)

Disetujui oleh,
Authorized Person



(Dr.dr.Aslichah M.Kes., AFP)

Disetujui Oleh :
Direktur RS. Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, SWT karena atas Rahmat-Nya Evaluasi Kinerja Manajemen Resiko Semester I pada Tahun 2026 telah dapat diselesaikan. Evaluasi kinerja ini digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengurangi cedera dan mengurangi risiko lain terhadap keselamatan pasien dan staf di Unit Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Rumah sakit yang menerapkan prinsip keselamatan pasien berkewajiban untuk mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko strategis dan operasional yang penting. Hal ini mencakup seluruh area baik manajerial maupun fungsional, termasuk area pelayanan, tempat pelayanan, juga area klinis. Rumah sakit perlu menjamin berjalannya sistem untuk mengendalikan dan mengurangi risiko. Manajemen risiko berhubungan erat dengan pelaksanaan keselamatan pasien rumah sakit dan berdampak kepada pencapaian sasaran mutu rumah sakit. Ketiganya berkaitan erat dalam suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya program manajemen risiko ini diharapkan dapat menjadikan sebuah pendekatan proaktif untuk membantu Rumah Sakit untuk memperbaiki, mengambil keputusan untuk keseimbangan optimal antara risiko, keuntungan dan biaya.

Akhir kata, kami dari Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya evaluasi kinerja Manajemen Resiko Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Semester I pada Tahun 2026.

Penyusun

Komite Mutu

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN
Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PENGESAHAN 2

KATA PENGANTAR 3

DAFTAR ISI4

1.1 Latar Belakang 5

1.2 Dasar Hukum5

1.3 Maksud dan Tujuan6

1.3.1 Maksud 6

1.3.2 Tujuan Umum6

1.3.3 Tujuan Khusus6

BAB II GAMBARAN UMUM7

2.1. Visi 7

2.2. Misi7

2.3. Motto 7

2.4. 7 Nilai Budi Utama 7

BAB III8

3.1 SDM 8

3.2 Pengembangan Pelayanan 10

3.3 Kinerja Produktifitas 11

BAB IV 84

4.1 Monitoring dan Evaluasi84

BAB V89

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang padat modal, padat teknologi, dan padat karya, serta memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif, rumah sakit dihadapkan pada berbagai potensi risiko. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko klinis (terkait keselamatan pasien), risiko non-klinis/fasilitas, risiko finansial, risiko hukum, hingga risiko reputasi. Kegagalan dalam mengelola risiko ini tidak hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa manusia.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (STARKES), setiap rumah sakit diwajibkan menerapkan tata kelola mutu dan keselamatan pasien yang komprehensif. Salah satu pilar utamanya adalah implementasi manajemen risiko yang terintegrasi di tingkat rumah sakit. Standar STARKES menuntut rumah sakit tidak hanya sekedar mengidentifikasi risiko, melainkan mampu melakukan mitigasi secara proaktif dan berkelanjutan demi menciptakan pelayanan yang aman (*safe*), efektif, dan berpusat pada pasien (*patient-centered care*).

Sebagai institusi yang berkomitmen terhadap mutu pelayanan, Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo telah menjalankan program manajemen risiko di seluruh unit kerja. Namun, efektivitas dari program tersebut tidak dapat diukur tanpa adanya evaluasi yang terstruktur terhadap hasil-hasil mitigasi yang telah dilakukan. Evaluasi ini krusial untuk mengetahui apakah tindakan korektif dan preventif yang telah diambil berhasil menurunkan derajat risiko (*risk level*) atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Oleh karena itu, Laporan Kinerja Manajemen Risiko Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo ini disusun. Laporan ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi formal yang memotret hasil mitigasi risiko di tingkat rumah sakit. Melalui laporan ini, manajemen dapat mengidentifikasi celah (*gap*) pelayanan, menentukan prioritas perbaikan, dan memastikan bahwa seluruh operasional Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo berjalan sesuai dengan standar akreditasi STARKES demi mewujudkan visi dan misi rumah sakit yang berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

- 1.2.1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 1.2.3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
- 1.2.4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- 1.2.5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
- 1.2.6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0107/Menkes/1354/2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko
- 1.2.7. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi RS
- 1.2.8. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 635.1/DPM/I-KEP/DIR/XII/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada
- 1.2.9. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1041.21/DPM/I-KEP/DIR/VII/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Manajemen Risiko ini adalah sebagai dokumen pertanggungjawaban penjaminan mutu (*quality assurance*) dan instrumen evaluasi formal untuk menilai efektivitas pelaksanaan program manajemen risiko yang telah diimplementasikan di RS Prima Husada Sukorejo

1.3.2 Tujuan Umum

Menurunkan atau mengeliminasi potensi risiko di seluruh lini pelayanan dan operasional Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo guna memastikan terciptanya lingkungan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu tinggi, dan memenuhi standar akreditasi STARKES

1.3.3 Tujuan Khusus

1. Mengevaluasi Efektivitas Mitigasi: Menilai sejauh mana tindakan korektif dan preventif yang telah dijalankan mampu menurunkan tingkat risiko (risk level) di RS Prima Husada Sukorejo
2. Memetakan Profil Risiko Terbaru: Memperbarui data daftar risiko (risk register) rumah sakit berdasarkan evaluasi berkala dan perkembangan kondisi operasional terkini
3. Menjamin Kepatuhan Standar STARKES: Memastikan pemenuhan elemen penilaian akreditasi STARKES, khususnya terkait regulasi tata kelola, manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK), serta keselamatan pasien
4. Menjadi Dasar Pengambilan Keputusan: Memberikan rekomendasi strategis bagi Direksi dan Manajemen RS Prima Husada Sukorejo dalam mengalokasikan sumber daya untuk perbaikan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement)
5. Meningkatkan Budaya Keselamatan (Safety Culture): Mendorong kesadaran dan keterlibatan aktif seluruh civitas hospitalia dalam melaporkan, menganalisis, dan memitigasi risiko di unit kerja masing-masing

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1. Visi

Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.

2.2. Misi

- 1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
- 2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
- 3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

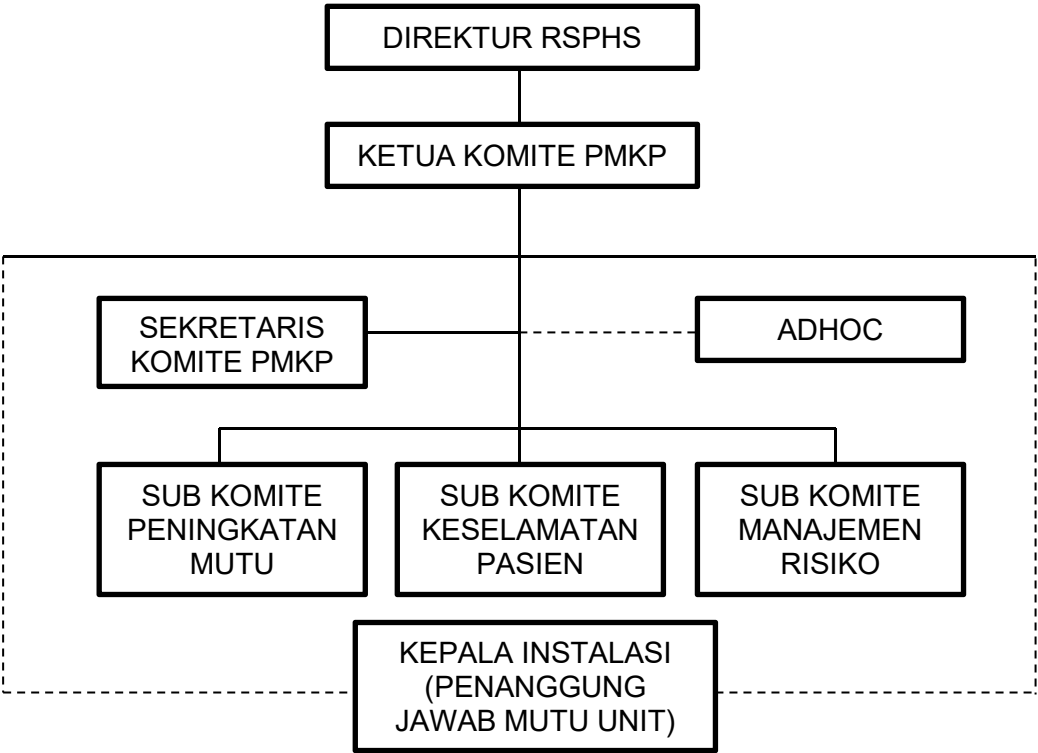
2.3. Motto

Sahabat Menuju Sehat

2.4. 7 Nilai Budi Utama

- 1. Jujur + Dipercaya
- 2. Tanggung Jawab
- 3. Visioner
- 4. Disiplin
- 5. Kerja sama
- 6. Adil
- 7. Peduli

2.5 SOTK Manajemen Risiko



BAB III
KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG
DICAPAI

3.1 SDM

3.1.1 Kebutuhan SDM

Implementasi program manajemen risiko yang komprehensif di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan terstruktur secara berjenjang. Pengelolaan risiko tidak bertumpu pada satu individu, melainkan dijalankan secara kolaboratif melalui koordinasi terintegrasi. Di tingkat korporat, kendali program berada di bawah Komite Mutu, khususnya Subkomite Manajemen Risiko, yang berfungsi sebagai motor penggerak. Tim ini diperkuat oleh tenaga kesehatan atau profesional manajemen yang telah memiliki sertifikasi keahlian dalam manajemen risiko rumah sakit (*Certified Risk Management*), yang bertugas menyusun strategi makro, menganalisis data agregat, serta menyusun laporan evaluasi ini untuk disampaikan kepada Direktur.

Untuk memastikan program berjalan di setiap lini pelayanan, rumah sakit menunjuk Person in Charge (PIC) Manajemen Risiko di setiap instalasi dan unit kerja, seperti ruang rawat inap, IGD, kamar operasi, farmasi, hingga unit non-klinis seperti K3RS dan IPSRS. Para PIC unit ini umumnya merupakan kepala ruangan atau staf senior yang memahami alur kerja operasional sehari-hari di areanya masing-masing. Mereka bertanggung jawab langsung dalam mengidentifikasi potensi bahaya di unit, mengawal implementasi mitigasi yang telah disepakati, serta melakukan pelaporan berkala terhadap insiden atau risiko baru yang muncul di lapangan.

Selain pemenuhan struktur organisasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM menjadi prioritas utama guna menjamin validitas hasil evaluasi dalam laporan ini. Seluruh jajaran pengelola risiko, baik di tingkat komite maupun unit, dibekali dengan pelatihan berkala terkait keselamatan pasien (*patient safety*), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), serta penguasaan instrumen analisis risiko formal seperti Risk Grading Matrix, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), dan Root Cause Analysis (RCA). Melalui sinergi SDM yang kompeten dan terstruktur ini, Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo optimis dapat terus menekan tingkat risiko operasional sejalan dengan pemenuhan standar akreditasi STARKES.

3.1.2 Orientasi

Telah dilakukan orientasi manajemen risiko kepada 1 orang staf baru dari MFK melalui diklat internal MFK pada tanggal 22-23 Mei 2026.

3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Peserta yang mengikuti pelatihan terdiri dari PIC Mutu Unit dan Kepala Ruang, dengan hasil :

No	Sasaran	Jumlah				Presentasi peserta
		Peserta Diundang	Peserta yang Mengerjakan		Peserta yang tidak mengerjakan pre & post	
			Pre Test	Post Test		
1	IGD	3	2	2	1	78,05%
2	IRJA	4	2	2	2	50%
3	IRNA 2A	3	1	1	2	33,34%
4	IRNA 2B	4	2	2	2	50%
5	IRNA 3A	3	3	3	0	100%
6	IRNA 3B	4	2	2	2	50%
7	IKO	3	1	1	2	33,34%
8	Maternitas	3	3	3	0	100%
9	PONEK	1	1	1	0	100%
10	Neonatologi	3	2	2	1	66,66%

No	Sasaran	Jumlah				Presentasi peserta
		Peserta Diundang	Peserta yang Mengerjakan		Peserta yang tidak mengerjakan pre & post	
			Pre Test	Post Test		
11	ICU	2	2	2	0	100%
12	Radiologi	3	1	1	2	33,34%
13	Laboratorium	3	2	2	1	66,66%
14	Farmasi	3	2	2	0	100%
15	Gizi	2	2	2	0	100%
16	Rekam Medis	2	2	2	0	100%
17	SDM	2	1	1	1	50%
18	Kesekretariatan	1	1	1	0	100%
19	Driver	2	1	1	1	50%
20	Pemulasaraan Jenazah	1	1	1	0	100%
21	ATEM-IPSRs	2	2	2	0	100%
22	CSSD-Laundry	4	4	4	0	100%
23	CS	7	6	6	1	85%
24	Keamanan	1	1	1	0	100%
25	Gudang Umum	1	1	1	0	100%
26	Komite PPI	1	1	1	0	100%
27	Komite PKRS	1	1	1	0	100%
28	Asuransi Center	2	1	1	1	50%
29	Humas dan Markerting	2	1	1	1	50%
30	MOD-MPP	2	1	1	1	50%
31	Prognas	4	2	2	2	50%
32	IT	2	1	1	1	50%
33	Geriatric	1	1	1	0	100%
34	Hemodialisa	2	1	1	1	50%
Total		53	39	39	13	73,58%

Pelatihan manajemen risiko diinsisikan dalam pelatihan PMKP melalui perwakilan dari unit dan diwajibkan kepada seluruh kepala ruang. Pelatihan ini dihadiri oleh 34 unit kerja baik dari pelayanan, penunjang dan umum. Jumlah peserta yang ditargetkan adalah 53 orang dengan hasil menunjukkan bahwa terdapat 39 (73,58%) orang staf yang hadir dan 13 (26,32%) orang tidak hadir dengan kendala karena bertabrakan dengan jadwal shift. Beberapa unit dengan kehadiran 100% adalah IRNA 3A, Maternitas, PONEK, ICU, Farmasi, Gizi, RM, Kesekretariatan, Pemulasaraan Jenazah, ATEM-IPSRs, Keamananan, Gudang Umum, PPI, PKRS, dan Geriatric. Hal ini menunjukkan potensi positif untuk meningkatkan semangat staf dalam mengikuti pelatihan secara aktif dan reaktif.

3.2. Pengembangan Pelayanan

3.3 Kinerja Produktifitas

3.3.1 Profil Risiko

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Controllability	Bobot (8) (5x6)	Rangking (9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (5x6)	(8) (5x6)	(9)
1	Risiko Non Klinis	Kurangnya kelengkapan penulisan DPJP dalam penulisan rekam medis, yang menyebabkan adanya pending dan audit dan serta berdampak pada cashflow rumah sakit	kurangnya kelengkapan dalam melengkapi berkas klaim rawat jalan dan rawat inap	5	5	3	1	1
2	Risiko keuangan	Dikarenakan adanya kerusakan alat radiologi Kemungkinan biaya perbaikan tinggi sehingga menyebabkan kerugian keuangan Rumah Sakit	Dikarenakan adanya kerusakan alat radiologi	5	5	3	1	2
3	Klinis	Dikarenakan beban kerja yang tinggi dan kurang konsentrasi saat checking akhir Kemungkinan terjadi medication error salah obat UDD Sehingga pasien salah obat dan berisiko mengalami efek samping/toksisitas	Dikarenakan beban kerja yang tinggi dan kurang konsentrasi saat checking akhir	5	4	3	1,2	3

Keterangan Controlability (Pengendalian) :

- 1 : easy (mudah untuk dikontrol)
- 2 : moderate easy (agak mudah dikontrol)
- 3 : moderate difficult (agak sulit dikontrol)
- 4 : difficult (sulit untuk dikontrol)

3.2 Rencana Penanganan Risiko

				Alternatif Teknik Penanganan Risiko	Pengendalian Yang Sudah Ada	Rencana Pengendalian		
--	--	--	--	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------	--	--

N o	Kegiatan	Sasaran	Resiko (Prioritas/ Sangat Tinggi)	Opsi Teknik Penanganan Resiko	Uraian Penanganan Resiko	Pengendalian yang sudah ada	Efektif / Kurang Efektif	Pengendalian yang harus ada	Kegiatan	Waktu	Jenis (Detektif (D), Preventif (P), Korektif (K))	Pemilik Resiko	Penanggung Jawab TL Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kelengkapan berkas klaim rawat jalan dan rawat inap	Untuk pengajuan klaim rawat jalan dan rawat inap	Kemungkinan terdapat pending, audit dan tidak layak klaim rawat jalan dan rawat inap	Cegah Kerugian	Bekerjasama dengan unit untuk reminder kelengkapan berkas pada DPJP	Melakukan evaluasi Dokter melalui OPPE	Cukup Efektif	Monitoring & evaluasi kelengkapan berkas klaim	Evaluasi Kepatuhan terhadap Reminder dan Followup kelengkapan berkas pada DPJP melalui Unit	Setiap hari	Preventif (P)	Seluruh Unit Kerja	Kepala Ruang dan Verifikator
2	Operasional layanan radiologi	Memberikan layanan berkelanjutan	Kemungkinan terjadinya pending dalam diagnosis yang mengancam keselamatan pasien	Cegah Kerugian	Program preventive maintenance terjadwal, pencatatan riwayat kerusakan alat	SOP upaya maintenance alat terjadwal	Kurang Efektif	Supervisi petugas IPSRS dan membuat evaluasi pelaksanaan pengecekan	Pelatihan User (Application Training) - Contingency Plan, bekerjasama dengan instansi lain saat alat trouble	Setiap ada upgrade software	Preventif (P)	Radiologi	Kepala Ruang Radiologi, IPSRS
3	Proses penyerahan obat UDD di Instalasi Farmasi	Pelayanan obat ke pada pasien melalui serah terima obat di unit	Kemungkinan terjadi medication error salah obat UDD	Cegah Kerugian (Mengurangi Probabilitas)	- SOP Penyerahan obat UDD Rawat Inap - Melakukan Double check saat penyiapan obat, -	Pembuatan SPO cara penyerahan obat UDD mensosialisasikan kepada seluruh staf saat operan jaga maupun rapat bulanan	Kurang Efektif	Monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap SOP UDD	Laporan kejadian kesalahan dalam UDD	Setiap bulan	Preventif (P)	Instalasi Farmasi	Kepala Ruang Instalasi Farmasi

					Penempelan label High Alert dan LASA, dan -Melakukan pekerjaan dengan hati- hati, supervisi apoteker -Pembuatan FMEA								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

4.1 Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Kegiatan : Kelengkapan berkas klaim rawat jalan dan rawat inap

Sasaran Kegiatan : Pengajuan klaim rawat jalan dan rawat inap

No	Risiko (Prioritas)	Penanganan			Usulan perbaikan	Waktu pemantauan		PJ Pemantauan
		Rencana	Realisasi	Yang belum tertangani		Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kemungkinan terdapat pending , audit dan tidak layak klaim rawat jalan dan rawat inap	Evaluasi Kepatuhan terhadap Reminder dan Followup kelengkapan berkas pada DPJP melalui Unit	- Monev kepatuhan & evaluasi jumlah berkas pending setiap bulan - Terdapat Tren peningkatan klaim pending RITL dengan hasil : peningkatan 0,48% dari Bulan sebelumnya	Masih ada berkas yang pending karena kurang kelengkapan atau hasil feedback dari asuransi kesehatan	Memaksimalkan tim yang bertanggungjawab atas kelengkapan RM di unit termasuk petugas yang menjadi PJ untuk bertanggungjawab terhadap followup pada DPJP	Setiap bulan	Setiap bulan	Kepala Ruang Rawat Inap dan Rawat Jalan
2		Evaluasi sensus indikator mutu Asuransi Center	Sensus harian indikator mutu terlaksana	Evaluasi baru dapat dilakukan diakhir periode setelah feedback dari asuransi	Segera dilakukan pengisian sensus mutu oleh asuransi center sesaat setelah mendapatkan feedback	Setiap bulan	Setiap bulan	

Kegiatan : Operasional layanan radiologi
Sasaran Kegiatan : Pelayanan yang cepat dan akurat

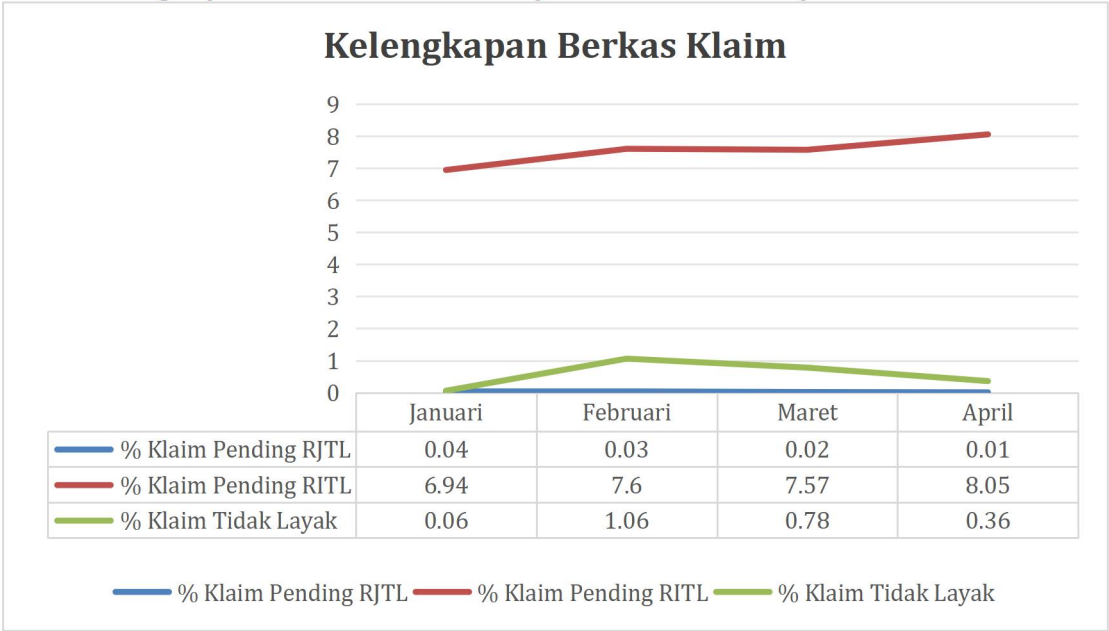
No	Risiko (Prioritas)	Penanganan			Usulan perbaikan	Waktu pemantauan		PJ Pemantauan
		Rencana	Realisasi	yang belum tertangani		Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kemungkinan terjadinya pending dalam diagnosis yang mengancam keselamatan pasien	Pelatihan User (Application Training)	Pelatihan oleh vendor terealisasi pada staf radiologi sesaat setelah CT-Scan di upgrade	Belum semua staf mendapatkan diklat dari vendor, pelatihan atau diklat dilakukan melalui sharing informasi antar staf	Penyaluran informasi oleh staf yang telah mendapatkan diklat oleh vendor	Setiap bulan	Setiap bulan	Kepala Ruang Radiologi, IPSRS
2		Contingency Plan, bekerjasama dengan instasi lain saat alat trouble	Terdapat rencana yang terstruktur yang tercerminkan pada grup koordinasi	Penumpukan jumlah pasien yang harus dilakukan CT-Scan karena keterbatasan transportasi	Memperhatikan prioritas kondisi pasien yang hendak dilakukan CT-Scan dengan mitra Penambahan staf driver saat penumpukan pasein CT-Scan	Setiap bulan	Setiap bulan	Kepala Ruang Radiologi, Kabid Penunjang

Kegiatan : Proses penyerahan obat UDD di Instalasi Farmasi
Sasaran Kegiatan : Ketepatan Pelayanan obat ke pada pasien melalui serah terima obat di unit

No	Risiko (Prioritas)	Penanganan			Usulan perbaikan	Waktu pemantauan		PJ Pemantauan
		Rencana	Realisasi	yang belum tertangani		Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kemungkinan terjadi medication error salah obat UDD	Monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap SOP UDD	Laporan IKP akibat medication error saat UDD menurun terutama setelah dilakukan supervisi SOP dan audit oleh kepala ruang	Terdapat beberapa kejadian obat tidak sesuai dengan etiket	Audit rutin saat staf melakukan UDD	Setiap bulan	Setiap bulan	Kepala Ruang Instalasi Farmasi

4.2 Hasil Pemantauan

4.2.1 Kelengkapan berkas klaim rawat jalan dan rawat inap

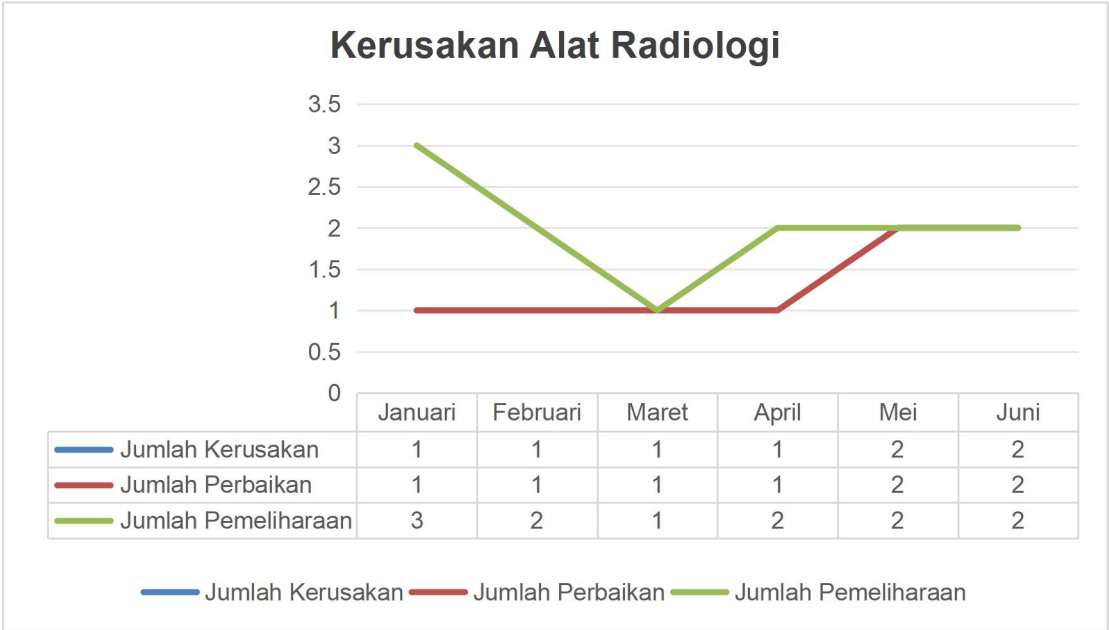


Gambar 1. Kelengkapan Berkas Klaim Rawat Jalan

Analisis :

Klaim pending rawat jalan mengalami peningkatan tren yang signifikan dengan selisih nilai 0,48% dari bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan tanggungjawab staf untuk patuh terhadap kelengkapan dokumen sebelum disetorkan kepada asuransi center. Tren ini berbanding terbalik dengan persentase klaim tidak layak yang semakin menurun dengan gap 0,42% dari bulan sebelumnya.

4.2.2 Risiko Kerusakan Alat Radiologi



Gambar 2. Risiko Kerusakan Alat Radiologi

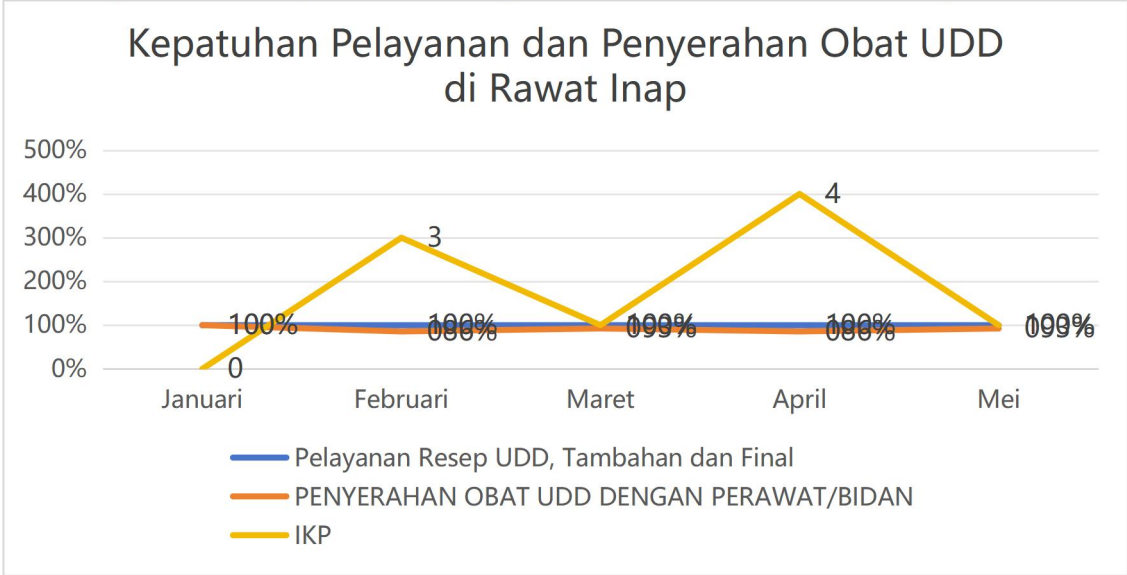
Analisa :

Kerusakan alat radiologi berbanding lurus dengan perbaikan alat. Namun untuk pemeliharaan alat ditemukan ketidakkonsistenan dari staf. Kerusakan alat masih ditemukan pada setiap bulan kemungkinan dapat berkaitan dengan tidak konsistennya dalam melakukan pemeliharaan.

4.2.1 Tabel PDSA Risiko Kerusakan Alat Radiologi

Problem	Kerusakan alat radiologi masih ada disetiap bulan dengan pemeliharaan yang tidak dilakukan pada seluruh alat
Step	Melakukan supervisi dan pemetaan terkait alasan tidak dilakukannya pemeliharaan rutin yang dapat memicu terjadi kerusakan alat vital.
Plan	1. Masalah yang ditemukan: Kerusakan alat yang masih ada disetiap bulannya dengan pemeliharaan yang tidak dilakukan secara konsisten. 2. Tujuan: Meningkatkan pemeliharaan rutin dan mencakup seluruh alat vital radiologi oleh staf ATEM 3. Rencana Aksi: a. Melakukan audit pada saat flow pasien meningkat b. Observasi dan analisis celah kemungkinan terjadinya kerusakan c. Refreshment oleh tim ATEM dalam penggunaan alat sesuai dengan SOP
Do	1. Memberikan feedback dan pembinaan langsung kepada staf yang ditemukan tidak sesuai prosedur. 2. Pelaporan kerusakan alat secara riil time.
Study	1. Pemeliharaan alat mengalami peningkatan di bulan Mei dan Juni 2. Kerusakan alat disebabkan karena software yang bermasalah 3. Staf radiologi melakukan penggunaan alat sesuai dengan SOP 4. Staf ATEM melakukan pemeliharaan pada alat yang vital 1 bulan sekali 5. Pemeliharaan alat tidak dilakukan pada semua alat karena penggunaan alat yang tinggi
Action	1. Menyusun jadwal pemeliharaan mandatori (window time) antara Karu Radiologi dan Tim ATEM. 2. Melakukan update/maintenance software berkala bekerja sama dengan IT RS atau vendor alat, serta membuat sistem backup/restart harian sesuai panduan vendor 3. Meningkatkan peran Karu untuk mengawasi kepatuhan jadwal pemeliharaan dan memastikan alat "dibebaskan" saat tim ATEM menjadwalkan servis.

4.2.3 Kepatuhan Pelayanan dan Penyerahan Obat UDD di Rawat Inap



Gambar 3. Kepatuhan Pelayanan dan Penyerahan Obat UDD di Rawat Inap

Analisa :
Kepatuhan Pelayanan dan Penyerahan Obat UDD di Rawat Inap relatif dilakukan sesuai dengan SOP. Namun terdapat indikator pada penyerahan obat UDD dengan perawat/bidan diruangan yang masih naik turun dikarenakan kurangnya double crosscheck saat serah terima akibat terburu-buru atau pada obat yang terselip terutama pada obat high alert.

4.2.2 Tabel PDSA Kepatuhan Pelayanan dan Penyerahan Obat UDD di Rawat Inap

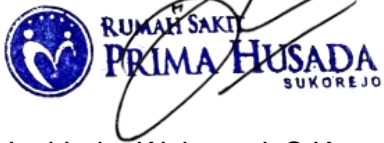
Problem	Masih terjadinya insiden/kesalahan dalam proses serah terima obat UDD antara tenaga farmasi dengan perawat/bidan di ruangan rawat inap. Masalah ini utamanya dipicu oleh kurangnya implementasi crosscheck dua arah, terutama pada kondisi volume obat yang banyak (sehingga rentan terselip) dan pada kelompok obat High Alert (kewaspadaan tinggi)
Step	Melakukan telaah proses (alur mapping) serah terima obat saat ini, mengidentifikasi titik kritis (critical point) terjadinya kelalaian, dan menetapkan metode crosscheck yang wajib disepakati bersama antara Farmasi dan Keperawatan/Kebidanan.
Plan	Masalah yang ditemukan: Kesalahan serah terima obat UDD karena lemahnya crosscheck dua arah, risiko obat terselip pada kuantitas banyak, dan kurangnya penandaan/perhatian khusus pada obat High Alert. Tujuan: Mencapai 100% kepatuhan pelaksanaan crosscheck dua arah saat serah terima obat UDD dan menurunkan angka insiden kesalahan obat (zero accident) dalam waktu 1 bulan. Rencana Aksi: a. Pemisahan & Labeling Makro, dengan tertib dalam melakukan penempelan label High Alert pada obat LASA b. Metode "Double Check Dua Arah"
Do	1. Petugas Farmasi mengantarkan obat UDD ke ruangan pada jam yang ditentukan dan melakukan verifikasi langsung (membaca keras nama obat dan jumlahnya) bersama perawat/bidan jaga. 2. Jika ditemukan ketidaksesuaian/obat terselip saat verifikasi, obat langsung diperbaiki saat itu juga sebelum ditandatangani.
Study	1. Masih ada obat yang terskip karena terlalu banyak, sehingga obat high alert masih ada yang salah 2. Obat yang salah ditemukan pasca serah terima yang menandakan tidak dilakukan crosscheck dua arah secara teapt
Action	1. Melakukan supervisi yang dibantu oleh kepala ruang unit untuk memastikan crosscheck dua arah tepat 2. Re-sosialisasi terhadap kepatuhan penempelan stiker High Alert pada obat LASA

BAB V PENUTUP

Demikian laporan manajemen resiko RS Prima Husada Sukorejo Semester I Tahun 2026, semoga dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana penanganan yang dilakuka

Pasuruan, 31 Juni 2026

Menyetujui,
Direktur Rumah Sakit Prima
Husada Sukorejo



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep)

Penyusun Ketua Komite Mutu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mariatul Rochmawati N.W.', with a stylized arrow at the end.

(Ns. Mariatul Rochmawati N.W, S.Kep)

